EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	66735
SERVICIO	:	UTI HSC			
FECHA	:	2023-06-30 13:14:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ROSALBA MUNOZ VILLALOBOS			RUN	: 7.392.487-1
F.Nac	: 26-05-2023	Edad	: 0 AÑO, 1 MES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-06-23	Fecha Egreso	: 2023-06-30 13:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. INSUFIICENCIA RESPIRATORIA AGUDA, RECUPERADA:
- NAC MULTIFOCAL, EN TRATAMIENTO
- EPOC POR BIOMASA EXACERBADO RECUPERADO
2. OBS SAHOS
3. ERC IIIB
3.1 ANEMIA NEFROGENICA MODERADA
4. HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON AM DE NEUMONIA MULTIFOCAL ATS REECIENTE, ACUDE POR EXACERBACION DE DISNEA DE 2 DIAS DE EVOLUCION, CONCOMITANTE EPISODIOS DE DESORIENTACION T/E INTERMITENTE Y SOMNOLENCIA, POR LO QUE ANTE EXACERBACION DE CLINICA Y TOS HUMEDA ACUDE A URGENCIA DONDE REALIZAN PARACLINICOS, INICIAN MANEJO CON BRONCODILATACION Y CORTICOIDES EV , SIN EMBARGO EN VISTA DE PERSISTENCIA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA Y CLINICA ANTES DESCRITA SOLICITAN EVALUACION UTI. ANTE HALLAZGOS COMPATIBLES CON HIPERCAPNIA SINTOMATICA SE DECIDE INGRESO PARA MANEJO CON VMNI. DURANTE EVOLUCION SE LOGRA REHABILITACION RESPIRATORIA SIGNIDFICATIVA CON DESTE PROGRESIVO DE VMNI HASTA LOGRAR O2 POR NRC MAXIMOA 1LT. PARAMETROS INFLAMTORIOS BAJOS. EN VISTA DE COMPENSACION RESPIRATORIA, TOLERANCIA A KINESIOTERAPIA MOTORA Y RESP, SE DECIDE DERIVAR A HOSPITALIZACION DOMICILIARIA PARA CONTINUAR KNT Y CONTROL POR POLICLINICO DE MEDICINA INTERNA.

PLAN DE MANEJO:

KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA POR 7 DIAS POR HODOM
REPOSO RELATIVO
O2 DOMICILIARIO MAXIMO 1 LT EN CASO DE DISNEA O DESATURACION MENOR DE 85% DURANTE EVALUACION POR KNT.
CABECERA DE CAMA A 30-45° DURANTE EL SUEÑO
I/C BRONCOPULMONAR
CONTROL POR POLICLINICO DE MEDICINA INTERNA EN 2 SEMANAS

INDICACIONES AL ALTA

1. PREDNISONA 20 MG AL DIA POR 3 DIAS, LUEGO PREDNISONA DE 5MG 2 C/24HS POR 5 DIAS LUEGO 1 DE 5MG C/24HS POR 7 DIAS.
2. BROMURO IPRATROPROPIO 4PUFF/4HS
3. SALBUTAMOL 4PUFF C/6HS
4. SALMETEROL 2 PUFF C/12HS
5. LEVOFLOXACINO 500MG C/24HS POR 7 DIAS
6. AMLODIPINO 10MG C/24HS
7. HIDRALAZINA 50MG C/8HS
8. ACIDO FOLICO 5MG 1 C/24HS
9. FIERRO+VITAMINA 1 C/24HS

OBSERVACIONES:

EN CASO DE SIGNOS DE ALARMA EXPLICADOS A FAMILIAR DEBERA ACUDIR NUEVAMENTE A URGENCIAS

SUNSHYMAR GOMES DUARTE
MEDICO TRATANTE
27337994-0

JEFE SERVICIO